

Traumatisme de l'abdomen

Face à une urgence ou une détresse vitale, ou en cas d'aggravation

- appliquer la conduite à tenir adaptée et réaliser en priorité les gestes d'urgence qui s'imposent ;

En l'absence de détresse vitale apparente

- appliquer la conduite à tenir face à une plaie grave ;
- adapter la conduite à tenir avec :
 - mettre la victime dans une position allongée, à plat dos, jambes fléchies¹ ;
 - rechercher l'existence de lésions dans le dos de la victime, particulièrement au cours de sa mobilisation ;
 - **En présence d'une éviscération :**
 - ne pas remettre les viscères en place ;
 - envelopper² les viscères dans un champ³ stérile humidifié⁴.
 - **En présence d'une femme enceinte :**
 - Toute femme enceinte victime d'un traumatisme violent (AVP, chute, coup dans l'abdomen) doit être considérée comme traumatisée de l'abdomen et faire l'objet d'une consultation dans un service d'urgence ou spécialisé.

¹ Cette position sera maintenue lors de son relevage et de son transport.

² Sans les mobiliser, ni les comprimer.

³ Ne pas utiliser de compresses.

⁴ Eau stérile ou sérum physiologique.